

Traitement psychotrope : quelle durée après un 1^{er} épisode ?

 Les traitements psychotropes sont encore trop souvent stigmatisés. Une représentation négative fréquente est que si on commence à prendre ces traitements, on ne pourra plus s'en passer, et qu'on les prendra toute sa vie.

 En l'état actuel des connaissances, on ne prescrit jamais un traitement psychotrope « à vie » pour les personnes qui présentent un 1^{er} épisode d'un trouble psychiatrique, y compris pour un 1^{er} épisode de trouble bipolaire ou de schizophrénie.

 La survenue d'un 1^{er} épisode indique la vulnérabilité pour ce trouble s'exprime à un moment donné et dans un contexte donné. Par exemple, quand on présente une vulnérabilité pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire, celle-ci peut s'exprimer après une consommation de cannabis. Une fois l'épisode traité, et le facteur déclenchant supprimé, cette vulnérabilité peut ne plus jamais s'exprimer.

 Le traitement psychotrope a pour objectif de traiter l'épisode et d'éviter une rechute ou récurrence précoce. Pour un épisode dépressif, maniaque ou psychotique, le délai d'action du traitement sur les symptômes est de plusieurs semaines.

 Une fois l'épisode aigu traité, l'équilibre est encore fragile pendant la phase de stabilisation (« convalescence »). Le traitement doit être maintenu plusieurs mois après la stabilisation puis la rémission des symptômes. Il est donc essentiel d'informer les personnes concernées sur la durée minimale de maintien du traitement après un 1^{er} épisode :

- ▶ dépressif : antidépresseur au moins 6 mois, 12 mois chez une personne âgée > 65 ans
- ▶ psychotique : antipsychotique au moins 12-24 mois
- ▶ maniaque ou hypomaniaque : thymorégulateur au moins 12-24 mois (? basé sur la pratique, absence notable de recommandations internationales)

! Dans tous les cas, l'arrêt doit être progressif et envisagé exclusivement en cas de rémission des symptômes : il ne s'agit pas que tous les symptômes disparaissent totalement, mais que leur intensité soit faible. Si leur intensité reste élevée, il ne faut pas arrêter le traitement.

 En cas de rémission, la décision d'arrêt doit prendre en compte d'autres critères :

- ▶ exposition persistante à des facteurs de risque : par ex, usage de cannabis, événements stressants, etc
- ▶ échéance proche pour une étape importante scolaire ou professionnelle : par ex, on n'arrête pas un traitement un mois avant un concours
- ▶ risque de dommage majeur en cas de de nouvel épisode, par ex. risque suicidaire très élevé
- ▶ antécédents familiaux, troubles comorbides, etc.
- ▶ poursuite d'autres traitements notamment psychothérapeutiques

 Après plusieurs épisodes, la durée prévisible du traitement augmente. Un traitement au très long cours à visée préventive peut alors se discuter.

! Pour mémoire, les traitements hypnotiques et anxiolytiques doivent toujours être prescrits pour la 1^{ère} fois pour la durée la plus courte possible.

Références ↓

<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013881>

<https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.07.062>

